Arquitetura de Soluções Tecnológicas para a Saúde Mental de Mulheres Vítimas de Violência Psicológica no Brasil: *Análise de Mercado, Design Baseado no Trauma e Inovação em HealthTech*

O fenômeno da violência contra a mulher no Brasil, em especial a violência psicológica oriunda de relacionamentos abusivos, constitui-se como uma das crises de saúde pública mais persistentes e complexas da contemporaneidade. De acordo com os dados mais recentes do Instituto de Pesquisa DataSenado, em 2025, aproximadamente 3,7 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar, marcando uma série histórica que já completa duas décadas de monitoramento.[1] Embora tenha ocorrido uma redução marginal nos índices gerais em comparação ao biênio anterior, a cronicidade do abuso permanece alarmante: cerca de 21% das vítimas relatam conviver com episódios de violência por mais de um ano, evidenciando a dificuldade de rompimento do ciclo de abuso.[1] A violência psicológica, especificamente, apresenta-se como um precursor silencioso de formas mais graves de agressão, estando presente em 94% dos relatos de mulheres que buscam auxílio em redes de apoio, como o Projeto Justiceiras.[2] Este cenário exige uma resposta tecnológica que transcenda o simples acionamento emergencial e foque na reabilitação psíquica e no empoderamento das sobreviventes.[3]

A análise epidemiológica revela que a violência não ocorre em um vácuo, mas está intrinsecamente ligada à presença de outros vulneráveis, como crianças e adolescentes. Em 71% das agressões domésticas registradas no último ano, crianças estavam presentes, o que gera um impacto geracional de trauma e reforça a necessidade de intervenções que considerem o núcleo familiar como um todo.[1] Além disso, o perfil racial das vítimas demonstra que a violência de gênero no Brasil é atravessada pelo racismo estrutural: 56% das vítimas de violência sexual e 64% das vítimas de feminicídio são mulheres negras.[5] Em 2024, o país registrou 1.492 feminicídios, o maior número desde a implementação da lei em 2015, além de 3.870 tentativas de assassinato, o que representa um aumento de 19% em relação ao ano anterior.[5] Esses dados reforçam que a tecnologia em saúde deve ser desenhada com uma sensibilidade cultural e racial aguda para ser efetivamente inclusiva.[6]

O Impacto da Violência Psicológica na Saúde Mental e a Resposta Digital

A violência psicológica é definida legalmente no Brasil como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima ou controle do comportamento da mulher através de ameaça, humilhação ou isolamento.[8] As consequências clínicas desse abuso são devastadoras, incluindo o desenvolvimento de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), depressão grave, ansiedade generalizada e ideação suicida.[10] Estudos indicam que mulheres que sofrem

violência por parceiro íntimo (VPI) apresentam taxas de comorbidades mentais três a cinco vezes superiores às da população geral.[12] No entanto, a resposta dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil ainda enfrenta obstáculos significativos, como a dificuldade dos profissionais em identificar casos de abuso e a falta de terapeutas capacitados para lidar com intervenções focadas no trauma.[13]

Nesse contexto, as intervenções digitais emergem como uma solução viável para preencher as lacunas do sistema de saúde tradicional. Tecnologias como aplicativos móveis e plataformas de telepsicologia oferecem anonimato, redução de custos e a quebra de barreiras geográficas, permitindo que mulheres em áreas remotas ou sob vigilância constante acessem suporte especializado.[3] A pandemia de COVID-19 acelerou o desenvolvimento dessas ferramentas (Digital Mental Health Interventions - DMHIs), que provaram ser eficazes na melhoria de desfechos como regulação emocional e preparação para a segurança.[3] No entanto, a implementação de tais ferramentas exige uma atenção rigorosa à segurança do dado, uma vez que agressores frequentemente utilizam o monitoramento digital (stalking) como extensão do controle abusivo.[16]

Análise do Ecossistema de Soluções Tecnológicas no Brasil

O mercado brasileiro de soluções para violência contra a mulher é diversificado, englobando desde iniciativas governamentais integradas ao Sistema Único de Saúde (SUS) até redes de voluntariado de alta capilaridade. A evolução dessas ferramentas reflete uma transição do foco puramente punitivo para um foco de cuidado integral e preventivo.[18]

Redes de Apoio e Voluntariado: O Caso do Projeto Justiceiras

O Projeto Justiceiras representa uma das maiores redes online de combate à violência de gênero no Brasil, utilizando a tecnologia para conectar vítimas a uma força-tarefa multidisciplinar. Com mais de 16.000 voluntários ativos, a plataforma oferece orientação jurídica, psicológica e socioassistencial gratuita.[19] O fluxo de atendimento inicia-se por meio de um formulário confidencial que pode ser acessado via WhatsApp, garantindo uma porta de entrada discreta para a mulher.[2] Até março de 2026, o projeto já havia realizado mais de 60.000 atendimentos, demonstrando a escalabilidade de soluções que utilizam redes de colaboração digital para suprir a escassez de profissionais na rede pública.[19] O suporte psicológico é prestado por mais de 2.000 psicólogos voluntários, que realizam o acolhimento remoto via telemedicina, uma tecnologia essencial para mulheres que não podem se deslocar fisicamente sem despertar a suspeita do agressor.[19]

Aplicativos de Segurança e Emergência: SOS Maria da Penha e Mete a Colher

Focados na mitigação de riscos imediatos, aplicativos como o SOS Maria da Penha oferecem funcionalidades críticas de segurança. O recurso central é o botão de emergência, que aciona equipes de segurança com um único toque, além de permitir o compartilhamento de localização em tempo real.[20] Uma inovação importante deste aplicativo é o chat seguro para documentação de evidências, permitindo que a vítima armazene fotos e vídeos de agressões que servem como prova em processos legais posteriores.[20] Complementarmente, o aplicativo Mete a Colher foca no suporte emocional e na inserção no mercado de trabalho, reconhecendo que a dependência financeira é um dos principais fatores que impedem a saída do relacionamento abusivo.[21] Para garantir o sigilo, o aplicativo utiliza criptografia de ponta a ponta e deleta automaticamente o histórico de conversas a cada 24 horas, protegendo a usuária caso o agressor ganhe acesso ao dispositivo.[21]

A Digitalização da Saúde Pública: Meu SUS Digital e o Teleatendimento Nacional

Uma mudança paradigmática ocorreu em março de 2026 com o anúncio de um pacote nacional de teleatendimento em saúde mental voltado especificamente para mulheres vítimas de violência dentro do SUS.[18] Integrado ao aplicativo Meu SUS Digital, o serviço prevê a realização de 4,7 milhões de teleconsultas psicológicas por ano, com equipes formadas por psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais.[23] O acesso é feito através de um "mini app" dentro da plataforma oficial, onde a mulher realiza um cadastro de avaliação de risco e recebe o agendamento de forma remota.[18] Essa iniciativa é parte do Pacto Brasil para o Enfrentamento do Feminicídio e busca transformar o SUS no ambiente mais acolhedor para a mulher, integrando o suporte digital ao cuidado presencial na Atenção Primária.[18] Além da saúde mental, o governo federal incluiu serviços de reconstrução dentária para vítimas de agressão, reforçando a visão de saúde integral.[22]

Benchmarks Internacionais: Inovações em Autonomia e Segurança

Enquanto as soluções brasileiras avançam na integração com a rede de proteção, ferramentas internacionais como o myPlan e o Bright Sky introduzem conceitos avançados de auxílio de decisão e camuflagem tecnológica que servem de modelo para o desenvolvimento de novas

HealthTechs.[25]

myPlan: O Auxílio de Decisão Baseado em Evidências

Desenvolvido por pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, o myPlan é a primeira ferramenta de auxílio de decisão (Safety Decision Aid - SDA) validada por ensaios clínicos randomizados para sobreviventes de violência por parceiro íntimo.[25] O aplicativo não dita o que a mulher deve fazer, mas fornece um algoritmo de avaliação de perigo (Danger Assessment) que ajuda a usuária a identificar o nível de letalidade de sua situação atual.[26] Com base nas prioridades da mulher — como a segurança dos filhos, estabilidade financeira ou desejo de permanecer no relacionamento com segurança — o app gera um plano de segurança personalizado.[26]

O myPlan destaca-se por seus mecanismos de segurança robustos. Ele inclui um "Dummy PIN" (PIN de fachada): se a usuária for forçada pelo agressor a abrir o aplicativo, a inserção deste código secreto exibe uma interface inofensiva, como um site de culinária, ocultando todo o histórico de busca por ajuda.[26] Outras funcionalidades incluem o botão "Quick Exit" (Saída Rápida) em todas as páginas e a capacidade de trocar o ícone do aplicativo na tela inicial do celular para que ele pareça uma ferramenta utilitária comum.[25]

Bright Sky: Diretório Multilingue e Diário de Evidências em Nuvem

O Bright Sky, mantido pela Fundação Hestia, foca na educação e na coleta de provas sem deixar rastros digitais. Um de seus principais recursos é o "My Journal" (Meu Diário), onde a usuária pode registrar abusos em formato de áudio, texto ou foto. Diferente de outros apps, nenhum dado é salvo no dispositivo físico; as informações são enviadas diretamente para um e-mail seguro escolhido pela usuária.[16] Além disso, o aplicativo oferece suporte em cinco idiomas (incluindo Punjabi e Urdu), reconhecendo a vulnerabilidade adicional de mulheres imigrantes que podem não dominar a língua local e, por isso, enfrentar barreiras maiores para acessar o suporte tradicional.[16]

Tabela de Análise Comparativa de Soluções em Saúde Tecnológica

A tabela a seguir consolida as informações sobre as soluções existentes, permitindo uma visualização clara das funcionalidades e dos diferenciais de cada plataforma.

Solução	Âmbito	Funcionalidade Principal	Diferencial de Segurança	Alvo de Saúde Mental
Projeto Justiceiras	Brasil	Rede de voluntariado multidisciplinar.	Atendimento virtual sigiloso via WhatsApp/Formulário.	Acolhimento psicológico com 2.000+ voluntários. [19]
SOS Maria da Penha	Brasil	Botão de pânico e registro de evidências.	Chat criptografado para documentação legal.	Encaminhamento para redes de aconselhamento local. [20]
Meu SUS Digital	Brasil	Teleatendimento psicológico nacional.	Autenticação Gov.br e integração com o prontuário SUS.	4,7 milhões de sessões de telepsicologia/ano. [23]
Mete a Colher	Brasil	Suporte emocional e inserção laboral.	Exclusão automática de conversas a cada 24h.	Grupo de apoio e chat anônimo entre mulheres. [21]
myPlan	Internacional	Algoritmo de decisão e plano de segurança.	PIN de fachada (Dummy PIN) e ícone camuflável.	Redução de conflito decisional e estresse pós-trauma. [27]
Bright Sky	Internacional	Educação e diário de evidências em nuvem.	Armazenamento de mídia fora do dispositivo físico.	Questionários de saúde do relacionamento. [28]
PFA Mobile	Internacional	Primeiros socorros psicológicos (PSP).	Funciona offline e sem coleta de dados pessoais.	Estabilização emocional imediata pós-crise. [29]

Design Baseado no Trauma (Trauma-Informed Design) em Saúde Digital

Para que uma solução tecnológica em saúde mental seja eficaz para vítimas de relacionamentos abusivos, ela deve ser construída sob os princípios do Design Baseado no Trauma. O trauma altera a neurobiologia da usuária, afetando o sistema nervoso autônomo (Teoria Polivagal) e as capacidades cognitivas, como memória de curto prazo e foco.[7] Em

estados de hipervigilância (fight-or-flight), o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões lógicas, torna-se menos ativo, enquanto a amígdala dispara respostas de medo.[30] Portanto, interfaces complexas, com excesso de informações ou navegação confusa, podem causar frustração extrema ou até a desistência do uso.[6]

Princípios Fundamentais para UX/UI em HealthTechs de Violência de Gênero

De acordo com as diretrizes do SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) e do ITTIC, o design deve priorizar seis pilares: Segurança, Confiança e Transparência, Apoio entre Pares, Colaboração, Empoderamento e Escolha, e Sensibilidade Cultural.[6]

1. **Segurança e Previsibilidade:** A interface deve ser simples e previsível. O uso de "Quick Exit" (Saída Rápida) visível em todas as telas é um requisito de segurança física e psicológica, dando à mulher o controle sobre sua própria navegação.[17]
2. **Linguagem Compassiva e Clara:** Deve-se evitar o uso de jargões clínicos ou termos excessivamente técnicos. O conteúdo deve ser redigido de forma a validar a experiência da mulher, evitando a re-traumatização através de descrições gráficas desnecessárias.[30]
3. **Redução da Carga Cognitiva:** Usuárias traumatizadas podem ter dificuldade em absorver textos longos. O uso de recursos visuais simples, ícones intuitivos e informações fragmentadas (chunking) facilita a compreensão em momentos de estresse agudo.[4]
4. **Empoderamento e Agência:** A solução tecnológica deve atuar como uma ferramenta de suporte, e não como uma autoridade que dita ordens. Oferecer opções de escolha (ex: "você prefere ler sobre isso agora ou guardar para depois?") fortalece a autonomia da mulher, que muitas vezes foi suprimida no relacionamento abusivo.[6]

Lacunas de Mercado e Oportunidades de Inovação

A análise das soluções existentes revela que, embora existam excelentes ferramentas de emergência e suporte inicial, persistem lacunas críticas que representam oportunidades para novos empreendedores em tecnologia e saúde.

1. Reabilitação Terapêutica de Longo Prazo via TCC Digital

Existe uma carência de protocolos de Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) estruturados e entregues de forma digital para a recuperação pós-abuso. A TCC é a abordagem com maior evidência de eficácia para tratar depressão e ansiedade em vítimas de violência doméstica, ajudando na ressignificação de crenças de desvalor e na reconstrução da autonomia.[9] Uma solução que ofereça módulos de autoajuda baseados em TCC, com acompanhamento de baixo contato ou assíncrono, poderia escalar o atendimento que hoje é restrito por falta de

terapeutas especializados.[14]

2. Acessibilidade e Inclusão para Populações de Baixa Literacia

A maioria dos aplicativos atuais pressupõe um nível médio de educação e alfabetização funcional. No Brasil, onde o "digital divide" é acentuado, há uma oportunidade para soluções baseadas em voz, áudio e chatbots simplificados via WhatsApp que não exijam o download de novos aplicativos pesados.[15] O uso de interfaces baseadas em inteligência artificial (IA) para Primeiros Socorros Psicológicos, capazes de entender e responder com empatia em linguagem natural, pode democratizar o acesso ao suporte imediato.[3]

3. Integração de "Offline" com "Online" na Rede de Saúde

Ainda há uma desconexão entre o que a mulher faz no aplicativo e o atendimento que ela recebe na Unidade Básica de Saúde. Soluções que facilitem a continuidade do cuidado (continuum of care), permitindo que a mulher compartilhe seu diário de sintomas ou plano de segurança com profissionais de saúde de forma segura e criptografada, podem otimizar o diagnóstico e o acompanhamento clínico.[3]

Proposta de Nova Solução: Plataforma "Ressurgir"

Com base na análise das lacunas de mercado e das necessidades sociais, propõe-se o desenvolvimento de uma solução tecnológica denominada **Ressurgir**. Trata-se de uma plataforma de saúde digital híbrida, focada na reabilitação psicológica de longo prazo para mulheres sobreviventes de violência psicológica.

Arquitetura da Solução

- **Módulo de Terapia Digital:** Oferece micro-sessões de TCC e Terapia de Exposição Narrativa (NET), focadas em reduzir os sintomas de TEPT e fortalecer a autoestima. O conteúdo é entregue via áudio e vídeos curtos para facilitar o consumo por usuárias com fadiga mental ou baixa literacia.[14]

- **Chatbot de Primeiros Socorros Psicológicos (PSP):** Um assistente virtual baseado em IA generativa, treinado em protocolos éticos de saúde mental, disponível 24/7 para estabilização emocional em momentos de gatilho ou crise.[35]

- **Mecanismo de Camuflagem "Vapor":** O aplicativo não é instalado. Ele opera como um PWA (Progressive Web App) acessível via navegador em modo incôgnito, disfarçado como um portal de notícias ou blog de bem-estar. Não deixa rastros na biblioteca de apps do celular e utiliza o "Dummy PIN" para proteção de dados sensíveis.[17]

- **Conexão Direta com a AgSUS:** Integração com o ecossistema do Meu SUS Digital para encaminhamento direto a teleconsultas com especialistas, garantindo que a tecnologia sirva como ponte para o sistema público de saúde.[23]

Conclusões e Considerações Estratégicas

A criação de uma solução tecnológica de impacto social para a saúde mental de mulheres vítimas de violência psicológica no Brasil exige um equilíbrio delicado entre inovação técnica e sensibilidade humana. Os dados do DataSenado e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública confirmam que a violência é endêmica e requer intervenções sistêmicas.[1] A tecnologia, quando aplicada através do Design Baseado no Trauma, tem o potencial de romper o isolamento imposto pelo agressor e fornecer ferramentas de cura que o sistema de saúde tradicional, por vezes, falha em entregar na velocidade necessária.[4]

Para que novas iniciativas tenham sucesso, é imperativo que o desenvolvimento envolva mulheres com experiência vivida, garantindo que as ferramentas não apenas funcionem tecnicamente, mas que ressoem com a realidade emocional e cultural das usuárias.[32] O futuro das HealthTechs de violência de gênero no Brasil reside na integração profunda com o SUS e na utilização de IA ética para escalar o suporte psicológico, transformando o celular de uma ferramenta de monitoramento e controle em um instrumento de libertação e saúde mental.[3] O compromisso deve ser com a criação de tecnologias que não apenas registrem a dor, mas que pavimentem o caminho para a resiliência e a autonomia plena das mulheres brasileiras.[3]

Referências citadas

1. DataSenado: violência de gênero atinge 3,7 milhões de brasileiras ..., acessado em abril 29, 2026, https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2025/11/24/datasenado-violencia-de-genero-atinge-3-7-milhoes-de-brasileiras
2. Projeto Justiceiras lança cartilha no canal da SPS no YouTube - Secretaria da Proteção Social, acessado em abril 29, 2026, https://www.sps.ce.gov.br/2020/12/01/projeto-justiceiras-lanca-cartilha-no-canal-da-sps-no-youtube/
3. Help, near and far: a systematic review of post-COVID digital mental health solutions for domestic violence victims - PMC, acessado em abril 29, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12903268/
4. Digital self-help for people experiencing intimate partner violence: a qualitative study on user experiences and needs including people with lived experiences and services providers - PMC, acessado em abril 29, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10394820/
5. 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2025) - Dossiês do Instituto

Patrícia Galvão, acessado em abril 29, 2026, https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/dados-e-fontes/pesquisa/19o-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica-fbsp-2025/
6. A scoping review of trauma-informed care principles applied in design and technology, acessado em abril 29, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12304634/
7. What is Trauma-Informed Design? - Birdcall UX, acessado em abril 29, 2026, https://www.birdcallux.com/blog/what-is-trauma-informed-design
8. Instituto Maria da Penha - IMP, acessado em abril 29, 2026, https://www.institutomariadapenha.org.br/
9. TCC - Bianca, Brenda e Gabriela - Oficial.docx, acessado em abril 29, 2026, https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstreams/dad3539f-3d61-4ae4-8fed-faa37713d4b9/download
10. Violência entre Parceiros Íntimos e as Implicações para a Saúde da Mulher - Pepsic, acessado em abril 29, 2026, https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-82202020000100010
11. A Violência Doméstica Contra Mulheres: Contribuição da Terapia Cognitivo-Comportamental na Intervenção / Domestic Violence Against Women: Contribution of Cognitive- Behavioral Therapy to Intervention, acessado em abril 29, 2026, https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2951
12. Technology-based and digital interventions for intimate partner violence: A systematic review and meta-analysis - PMC, acessado em abril 29, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9419475/
13. São Paulo, Brasil Avaliação de intervenção para aprimorar a resposta da Atenção Primária à Saúde ao cuidado de casos de violência doméstica contra a mulher, acessado em abril 29, 2026, https://www.scielosp.org/article/csc/2024.v29n9/e02982024/
14. Os impactos da violência sobre a saúde mental global: contribuições da Terapia de Exposição Narrativa em diferentes siste - SciELO, acessado em abril 29, 2026, https://www.scielo.br/j/csp/a/68wDkzn6y6MvxGFtYh5Dn6z/?format=pdf&lang=pt
15. Digital Health Interventions for Depression and Anxiety in Low- and Middle-Income Countries: Rapid Scoping Review - PMC, acessado em abril 29, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12413575/
16. Bright Sky - Apps on Google Play, acessado em abril 29, 2026, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newtonmobile.hestia
17. Digital Interventions to Support and Treat Victims of Intimate Partner Violence: A Systematic Review - Hogrefe eContent, acessado em abril 29, 2026, https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1027/1016-9040/a000504
18. Mulheres em situação de violência terão atendimento on-line em saúde mental pelo SUS, acessado em abril 29, 2026, https://www.gov.br/mulheres/pt-br/central-de-conteudos/noticias/2026/marco/mulheres-em-situacao-de-violencia-terao-atendimento-on-line-em-saude-mental-pelo-sus
19. Projeto Justiceiras in Brazil - Find a Helpline, acessado em abril 29, 2026,

https://findahelpline.com/organizations/projeto-justiceiras
20. SOS Maria da Penha – Apps no Google Play, acessado em abril 29, 2026, https://play.google.com/store/apps/details?id=app3tecnos.mariadapenha&hl=pt
21. Mete a Colher | Cidadania 2.0, acessado em abril 29, 2026, https://cidadania20.com/projectos/meteacolher/
22. Meu SUS Digital reforça orientação sobre canais de proteção às mulheres no SUS, acessado em abril 29, 2026, https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2026/marco/meu-sus-digital-reforca-orientacao-sobre-canais-de-protecao-as-mulheres-no-sus
23. SUS ganha neste mês teleatendimento para mulheres expostas à ..., acessado em abril 29, 2026, https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-03/sus-ganha-neste-mes-teleatendimento-para-mulheres-expostas-violencia
24. Ministério da Saúde anuncia ações para mulheres vítimas de violência, incluindo teleatendimento em saúde mental e reconstrução dentária no SUS - Portal Gov.br, acessado em abril 29, 2026, https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2026/marco/ministerio-da-saude-anuncia-acoes-para-mulheres-vitimas-de-violencia-incluindo-teleatendimento-em-saude-mental-e-reconstrucao-dentaria-no-sus
25. myPlan: A decision aid for intimate partner violence survivors and their concerned friends and family - Technology, acessado em abril 29, 2026, https://jhu.technologypublisher.com/technology/56266
26. Adapting the myPlan safety app to respond to intimate partner violence for women in low and middle income country settings - PMC, acessado em abril 29, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7260790/
27. myPlan | Everyone Deserves to Be Safe in Their Relationships, acessado em abril 29, 2026, https://myplanapp.org/
28. UK Bright Sky - Hestia, acessado em abril 29, 2026, https://www.hestia.org/brightsky
29. PFA Mobile - PTSD: National Center for PTSD, acessado em abril 29, 2026, https://www.ptsd.va.gov/appvid/mobile/pfa_app_pro.asp
30. Trauma-informed design for UX content, acessado em abril 29, 2026, https://uxcontent.com/a-guide-to-trauma-informed-content-design/
31. Using trauma-informed principles in content design, acessado em abril 29, 2026, https://contentdesign.london/blog/using-trauma-informed-principles-with-content-design
32. Trauma-informed design research - by Jax Wechsler - UX Collective, acessado em abril 29, 2026, https://uxdesign.cc/trauma-informed-design-research-69b9ba5f8b08
33. Terapia Cognitivo-Comportamental para mulheres que sofreram ..., acessado em abril 29, 2026, http://www.scielo.edu.uy/pdf/cp/v13n2/pt_1688-4221-cp-13-02-249.pdf
34. Digital interventions for common mental health problems among older adults in low- and middle-income countries: a scoping review - PMC, acessado em abril 29, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12198822/

35. Full article: A case-specific psychological first aid AI recommendations app for rescue and first responders - Taylor & Francis, acessado em abril 29, 2026, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20008066.2025.2591567
36. Mixed Methods Findings of a Psychological First Aid Digital Peer Learning Program for Child-Supporting Professionals, acessado em abril 29, 2026, https://firstaidjournal.org/article/id/2835/
37. Aplicativos de enfrentamento à violência contra a mulher ... - UTFPR, acessado em abril 29, 2026, https://periodicos.utfpr.edu.br/cgt/article/download/13249/8445
38. PROTOCOL: Technology-based and digital interventions for intimate partner violence: A meta-analysis and systematic review - IDEAS/RePEc, acessado em abril 29, 2026, https://ideas.repec.org/a/wly/camsys/v17y2021i1ne1132.html
39. PROTOCOL: Technology-based and digital interventions for intimate partner violence: A meta-analysis and systematic review - PMC, acessado em abril 29, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8356356/